

Registro de hambre y saciedad

Empezar a notar lo que pasa en el cuerpo, sin juicio

En los TCA, las señales interoceptivas de hambre y saciedad suelen estar alteradas: algunas personas no las perciben, otras las perciben de forma distorsionada o las confunden con emociones. Este registro **no es para controlar lo que comés** — es para empezar a notar lo que pasa en el cuerpo, sin juicio.

— LA ESCALA DE HAMBRE-SACIEDAD

1-2**Hambre extrema** — mareos, debilidad, dificultad para concentrarse.**3-4****Bastante hambre** — estómago vacío, irritabilidad, pensamientos frecuentes en comida.**5****Neutral** — ni hambre ni saciedad, punto de equilibrio.**6-7****Satisfecha/o** — cómoda/o, podés seguir con tu día sin pensar en comida.**8-9****Llena/o** — estómago lleno, quizás algo incómodo.**10****Muy llena/o** — malestar físico, distensión.

— REGISTRO DEL DÍA Fecha: _____

COMIDA / MOMENTO	ANTES (HAMBRE)	A LA MITAD	DESPUÉS (SACIEDAD)	¿HAMBRE O EMOCIÓN?

REFLEXIÓN

1. ¿Pude reconocer el hambre física hoy? ¿Qué noté?

2. ¿Hubo momentos en que comí sin hambre o por emoción? ¿Qué pasaba?

Identificá la voz del TCA

Crear distancia entre el pensamiento y la acción

Es útil aprender a identificar los **pensamientos automáticos** que mantienen el trastorno —y a responderles desde otro lugar. No se trata de “pensar positivo”: se trata de crear distancia entre el pensamiento y la acción, y de responder con lo que vos sabés cuando no estás en el momento de máxima ansiedad.

EJEMPLOS FRECUENTES

PENSAMIENTO DEL TCA	DISTORSIÓN QUE CONTIENE	RESPUESTA POSIBLE
“Si como eso, lo voy a arruinar todo”	Todo-o-nada; catastrofización.	Comer un alimento no define ni arruina nada. No existe “arruinar”.
“No merezco comer”	Creencia nuclear de indignidad.	Todas las personas necesitan y merecen comer, sin condiciones.
“Si no hago ejercicio hoy, soy un fracaso”	Todo-o-nada; condicionamiento del valor propio.	Descansar es parte del cuidado, no una falla.
“El atracón demuestra que no tengo control”	Generalización; confunde conducta con identidad.	Un episodio no define quién soy. Es una señal de que algo me duele.

TU REGISTRO Fecha: _____

SITUACIÓN	PENSAMIENTO DEL TCA	EMOCIÓN	TU RESPUESTA

¿Qué tan difícil fue responder hoy? (1-10) ¿Qué lo hizo difícil?

La respuesta no tiene que convencerte en el momento — al principio alcanza con escribirla. La voz del TCA suele ser más intensa cuando estás cansada/o, bajo estrés o en situaciones sociales. Con el tiempo y el tratamiento, pierde fuerza.

Qué no decir — y qué decir en cambio

Las palabras importan especialmente en el contexto de un TCA. La investigación sobre Emoción Expresada —crítica, hostilidad y sobreprotección— muestra asociación con peores resultados y mayor riesgo de recaída. Estas frases nacen del amor; aun así, pueden hacer daño.

✗ EVITÁ DECIR

“Solo tenés que comer, no es tan difícil”

Comer activa una respuesta de miedo genuina, no una preferencia. Invalida el sufrimiento y refuerza que el trastorno es una elección.

✗ EVITÁ DECIR

“Qué bien te ves — estás más saludable”

Los comentarios sobre el cuerpo, aunque positivos, refuerzan que la apariencia es lo importante y pueden vivirse como “engordaste”.

✗ EVITÁ DECIR

“Antes eras tan linda/o — te estás destruyendo”

Combina crítica del presente con idealización del cuerpo pasado; profundiza la imagen corporal negativa y genera culpa y vergüenza.

✗ EVITÁ DECIR

“¿Ya comiste? / ¿Cuánto comiste hoy?”

Convierte cada interacción en vigilancia. La persona se siente controlada, puede mentir y aislarse. No enseña a comer: enseña a esconderse.

✗ EVITÁ DECIR

“Hacelo por mí / Si me amaras, comerías”

Los argumentos basados en culpa o deuda afectiva no generan recuperación: generan más vergüenza, más secreto y daño al vínculo.

✗ EVITÁ DECIR

“Ya estás mejor — no necesitás más tratamiento”

Los TCA saben ocultarse y la recuperación no es lineal. Puede llevar a abandonar el tratamiento cuando el riesgo de recaída sigue alto.

✓ EN CAMBIO

“Sé que esto es muy difícil para vos. Estoy acá.”

✓ EN CAMBIO

“Te noto con más energía. Me alegra verte.”

✓ EN CAMBIO

“Me preocupa cómo estás. ¿Podemos hablar?”

✓ EN CAMBIO

“¿Cómo estás hoy?” — sin referencia a la comida.

✓ EN CAMBIO

“Te quiero mucho. ¿Qué necesitás de mí ahora mismo?”

✓ EN CAMBIO

“¿Cómo te está yendo en el tratamiento? ¿Cómo te sentís vos?”

Si no sabés qué decir, el **silencio acompañado** vale más que las palabras equivocadas. Sentarte al lado, estar disponible sin exigir — también es comunicar.

Tareas para trastornos alimenticios

Herramientas para trabajar la relación con la comida y el cuerpo

1 · 2

1 Sorprender las trampas

Esta semana, prestá atención a los mensajes o pensamientos que te empujan hacia conductas alimentarias problemáticas. Llamalos “las trampas”.

¿CÓMO HACERLO?

1. Cuando llegue un pensamiento sobre comida, peso o figura que te genere malestar, anotalo.
2. Nombralo: “esta es una trampa”.
3. No tenés que combatirlo todavía — solo reconocerlo.
4. En la próxima sesión, miramos las trampas juntos/as.

Las trampas no son tuyas — son parte del problema. Vos sos quien las observa.

2 Una pequeña insubordinación por día

Cada día, hacé UN cambio pequeño que sea una señal de que vos tomás decisiones — no el trastorno.

¿CÓMO HACERLO?

1. Pensá: ¿qué pequeña cosa podría hacer hoy que vaya un poco en contra de lo que el trastorno me dice?
2. Muy pequeño: agregar un alimento, cambiar un horario, comer en un lugar diferente.
3. Hacelo y fijate cómo te sentís.
4. Anotalo.

No tiene que ser grande. Cada pequeño acto de rebeldía contra el trastorno cuenta.

3 El automasaje

Después de ducharte, dedicá 5 a 10 minutos a masajearte con crema, prestando atención a las sensaciones positivas de tu cuerpo.

¿CÓMO HACERLO?

1. Después de ducharte, tomá una crema hidratante.
2. Masajeate despacio, sin apurarte.
3. Prestá atención a las sensaciones: calor, textura, alivio.
4. Si aparecen pensamientos negativos sobre tu cuerpo, notalos sin desarrollarlos.

Al principio pueden aparecer emociones difíciles — es esperable. Comentáselo a tu psicóloga.

4 El momento de reflexión antes del atracón

Antes de que ocurra el atracón, sentate un momento y escribí qué estás sintiendo y qué creés que vas a sentir después.

¿CÓMO HACERLO?

1. Cuando notes el impulso, antes de actuar, sentate con un papel.
2. Escribí: ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a sentir después?
3. No hay respuesta correcta — solo date el espacio para observar.
4. Guardá el papel y traelo a sesión.

No es para que no ocurra — es para conocer mejor qué lo dispara. Esa información es valiosa.

5 Alternativas al atracón

Armá una lista de cosas que podrías hacer cuando sentís el impulso de darte un atracón. Escríbilas en papelitos y ponelas en una cajita.

¿CÓMO HACERLO?

1. Junto a tu psicóloga, hablá de qué actividades podrían ayudarte en ese momento.
2. Escribí cada opción en un papelito diferente.
3. Poné los papelitos en una cajita pequeña.
4. Cuando llegue el impulso, abrí la caja y elegí uno.

Funcionan mejor si las pensaste en un momento tranquilo — no durante la crisis. Por eso la caja.

6 Cambiando el atracón

Si va a ocurrir de todas formas, esta semana hacelo de una manera diferente a la habitual. Introducí cualquier pequeña variación.

¿CÓMO HACERLO?

1. Pensá: ¿cómo es habitualmente? ¿Solo/a? ¿En un lugar específico? ¿Con ciertos alimentos?
2. Esta semana, si ocurre, cambiá UNA cosa: el lugar, la compañía, los alimentos, el horario.
3. Anotá qué cambió y cómo te sentiste.

El objetivo no es que no ocurra. Es empezar a tener algo de control sobre cómo ocurre. Eso ya es un cambio.

7 Normalizando los alimentos (para bulimia)

Incorporá cinco comidas al día, incluyendo en alguna de ellas un alimento que solés evitar.

¿CÓMO HACERLO?

1. Organizá 5 momentos de comida: desayuno, almuerzo, merienda, cena y una colación.
2. En una de esas comidas, incluí un alimento que solés evitar o “prohibirte”.
3. Comé la cantidad que quieras en ese momento.
4. Anotá cómo te sentiste.

Esta tarea se trabaja en conjunto con tu psicóloga. No la hagas sola sin antes haberla planificado en sesión.